

13h30

INDICADO POR: Internet

X ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

ANTONIO JOSÉ SALGUEIRO

mora Paulo Alegre

IDADE: 65

PESO: 83

ALTURA: 1,68

PROFISSÃO: Servidor Federal

Aposentado.

INSS

SINTOMAS:

QUEIXAS: Ronco; Acorda "sem ar"; SED;

MEDICAMENTOS: Risperidona; Valsartan, ASS, Varapril (HAS).

MÉDICO: Dr. Jair Nishimura (Cardiologista) Juazeiro

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: bicicleta ergométrica - diário

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

HORA QUE DORME:

21h

HORA QUE ACORDA: 06h

COCHILHO (X) S () N

DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S (X) N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N

PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S (X) X NA SEMANA () N raro FDS.

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI: IV

IAH: 70,6 s/h SPO2: 54% SpO2 méd: 88%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

↓ N3: 4%

↑ N2: 75%

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA 2 stents

() ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

29/07/2025

Análise

Localização

Masc. Yulell

Silvia

05/08/25 Deixo P= 6-10 cmH2O

IAH= 9,9 s/h

mde mix: 9h15'

suco: 32,4 l/h

Natacha

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: ANTONIO JOSÉ SALGUEIRO

Data do Exame: 26-06-2025

Peso: 83 kg

Médico Solicitante: DR. JAIR TOSHIYUKI NISHIMURA

Sexo: Masculino

Idade: 65 anos

Altura: 1,68 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 26/06/2025 21:53 e finalizado às 27/06/2025 05:39.

A latência para início do sono foi de 20,5 min e a latência para o sono REM de 139,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 375,5 min, com eficiência do sono de 80,6 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 3,2 % de estágio N1, 75,0 % de estágio N2, 4,3 % de estágio N3 e 17,6 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 70,0 min. Ocorreram 358 despertares, sendo o índice de 46,1 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 442, sendo 410 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 32 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 70,6 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 63,6 e o IDR durante o sono NREM foi de 72,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 70,6 (nº/h), sendo 65,5 apneia/h e 5,1 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 88% e a mínima de 54%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 55,1 (nº/h), sendo que em REM foi de 57,3 (nº/h) e em NREM foi de 70,8 (nº/h). Permaneceu 40,9 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório acentuado (**70,6 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (**54%**);
3. Latência para o início do sono normal (**20,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**139,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**80,6 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Aumento do índice de despertares (**46,1 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**3,2 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (**75,0 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Diminuição do percentual do estágio N3 ondas delta (**4,3 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Diminuição do percentual do estágio REM (**17,6 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco constante verificado via sensor de ronco;

IR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

critério de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

critério de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

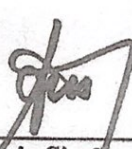
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57